

CAPÍTULO 10.22

Parasitosis – Segunda Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.022

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Parasitosis — Parte II

Hidatidosis (Equinococosis)

- **Agente:** *Echinococcus granulosus* (parásito de perros).
- **Contagio:** Alimentos contaminados con deposiciones de perro.
- **Localización:** Hígado (más frecuente) y pulmón.
- **Clínica:**
 - - Hepática: asintomática → absceso → dolor abdominal + fiebre
 - - Pulmonar: **Vómitica hidatídica** = tos + expectoración acuosa transparente ("agua de roca") + membranas (≠ absceso pútrido)
- **Diagnóstico:** Imágenes: ECO (hígado: quiste con tabiques / "rueda de carreta") o Rx Tórax (nivel hidroaéreo)
- **Tratamiento:** Albendazol × 6 semanas (previo) → **Cirugía** (definitivo). Alternativa en hígado: inyectoterapia (alcohol/suero hipertónico).
- **Notificación:** Diaria (no inmediata).
- **Prevención:** Desparasitar mascotas cada 3 meses + no alimentarlas con vísceras crudas.

Distomatosis Hepática (Fasciola hepatica)

- **Contagio:** Plantas acuáticas (berros silvestres). En Chile, hoy solo se venden berros hidropónicos.
- **Clínica:** **Ictericia + eosinofilia** (colestasis por gusano en vía biliar).
- **Diagnóstico:** Parasitológico (huevos en deposiciones) o Ecografía (gusano moviéndose en vía biliar).
- **Tratamiento:** **Triclabendazol** (mata todos los estadios larvarios). No usar prazicuantel.
- **Notificación:** Inmediata.

Amebiasis Intestinal

- **Agente:** *Entamoeba histolytica* (unicelular). Contagio fecal-oral.
- **Clínica:** Disentería aguda o crónica (simula enfermedad inflamatoria intestinal).
- - Complicación: Absceso hepático amebiano.
- **Diagnóstico:** Parasitológico de deposiciones (distinguir de amebas comensales no patogénicas).
- **Tratamiento:** **Metronidazol** VO × 7 días. Si absceso: Metronidazol EV ± drenaje (si > 10 cm o refractario).

Giardiasis

- **Agente:** *Giardia lamblia* (protozoo). Contagio fecal-oral.
- **Clínica:** Diarrea crónica + síndrome de malabsorción + meteorismo/distensión (simula enfermedad celíaca).
- **Diagnóstico:** Parasitológico de deposiciones.

- **Tratamiento:** **Tinidazol** (de elección) o Metronidazol.

Resumen de Tratamientos por Tipo de Parásito

TABLA 10.22.1: TIPO VS TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	
TIPO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Nematodos (gusanos redondos: Ascaris, Oxiuros, Triquina)	Mebendazol o Albendazol
Cestoides (gusanos planos: Tenia)	Prazicuantel
Tremátodos (fasciola / distoma)	Triclabendazol

| Protozoos (ameba, giardia) | **Metronidazol** o Tinidazol |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de zona rural consulta por dolor abdominal e ictericia. El hemograma muestra eosinofilia marcada. La ecografía muestra una imagen móvil en la vía biliar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Parasitosis – Segunda Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hidatidosis (deposiciones de perro): hígado (quistes con tabiques/rueda de carreta, absceso) y pulmón (bómica: agua clara + membranas en hollejo de uva). Tratamiento quirúrgico + albendazol 6 semanas previo.
- Distomatosis (berros silvestres/Fasciola hepatica): **ICTERICIA + EOSINOFILIA** = distomatosis (no hidatidosis). Tratamiento: triclabendazol. Notificación inmediata.
- Amebiasis (*E. histolytica*): disentería, simula colitis ulcerosa. *E. coli* es comensal normal. Tratamiento: metronidazol. Absceso: metronidazol EV, drenaje solo si refractario o >10 cm.
- Giardiasis (*G. lamblia*): diarrea crónica + malabsorción + meteorismo, simula enfermedad celíaca. Tratamiento: tinidazol (elección) o metronidazol.
- Prevención hidatidosis: desparasitar mascotas cada 3 meses, no dar vísceras crudas a perros.
- Resumen tratamientos: metronidazol (unicelulares), albendazol (gusanos cilíndricos), prazicuantel (gusanos planos), triclabendazol (fasciola).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PARASITOSIS - SEGUNDA PARTE)**PREGUNTA 1**

Paciente de zona rural consulta por dolor abdominal e ictericia. El hemograma muestra eosinofilia marcada. La ecografía muestra una imagen móvil en la vía biliar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Hidatidosis hepática
- B)** Distomatosis hepática (Fasciola hepatica)
- C)** Coledocolitiasis
- D)** Absceso hepático amebiano
- E)** Ascariasis biliar

PREGUNTA 2

Paciente con tos productiva con expectoración de agua transparente y membranas. La radiografía de tórax muestra una imagen redondeada con nivel hidroaéreo en lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento?

- A)** Antibióticos endovenosos por absceso pulmonar
- B)** Albendazol por 6 semanas seguido de cirugía
- C)** Inyectoterapia percutánea con alcohol
- D)** Praziquantel oral por 3 días
- E)** Observación y control radiológico

PREGUNTA 3

Paciente con diarrea crónica con mucosidad y sangre. Se sospecha enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué examen adicional es importante solicitar antes de iniciar tratamiento inmunosupresor?

- A)** Hemograma con recuento de eosinófilos
- B)** Parasitológico de deposiciones
- C)** Serología para *Clostridium difficile*
- D)** Test de Graham
- E)** Coprocultivo para *Salmonella*

RESUMEN: PARASITOSIS - SEGUNDA PARTE

Esta clase completa el tema de parasitosis abordando hidatidosis, distomatosis hepática, amebiasis y giardiasis. La hidatidosis (*Echinococcus granulosus*) se contagia por alimentos contaminados con deposiciones de perro. Afecta hígado (quistes con tabiques, imagen en rueda de carreta, complicación con absceso hepático) y pulmón (bómica: tos con agua clara y membranas en hollejo de uva). Diagnóstico con imágenes (ecografía hepática, radiografía pulmonar). Tratamiento quirúrgico con albendazol previo por 6 semanas. Alternativa hepática: inyectoterapia con alcohol o suero hipertónico. Prevención: desparasitar mascotas cada 3 meses. Notificación diaria. La distomatosis hepática (*Fasciola hepatica*/distoma/duela) se contagia por comer berros silvestres (plantas acuáticas). Clínica: ictericia más eosinofilia (diferencia con hidatidosis que es asintomática sin eosinofilia). Diagnóstico con parasitológico o ecografía (gusano en vía biliar). Tratamiento con triclabendazol. Notificación inmediata. La amebiasis (*Entamoeba histolytica*) produce disentería amebiana (aguda o crónica), simula enfermedad inflamatoria intestinal. Puede producir abscesos hepáticos. Diagnóstico con parasitológico (diferenciar de *Entamoeba coli* que es comensal). Tratamiento con metronidazol oral (o EV si absceso). Drenaje solo si refractario o mayor de 10 cm. La giardiasis (*Giardia lamblia*) produce diarrea crónica con síndrome de malabsorción y meteorismo, simulando enfermedad celíaca. Diagnóstico con parasitológico. Tratamiento con tinidazol (elección) o metronidazol.